

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle IV.5	Bezeichnung des Dokumentes: Sterbegleitung und Versorgung Verstorbener Umgang mit Nachlass in unserem Pflegedienst	

Der Tod ist der Begleiter des Lebens. Durch unsere Tätigkeit kommen wir mit Menschen in Berührung die sich aus unterschiedlichsten Lebenshintergründen, mit unterschiedlichsten medizinischen Indikationen und in unterschiedlichsten pflegerischen Situationen dem Vergehen stellen müssen. Die Unterstützung gerade in solchen Lebenskrisen ist Teil unseres Pflegemodells.

Wir wissen, dass viele unserer Pflegebedürftigen sich sehr wohl mit dem Sterben auseinandersetzen. Dies setzt auf pflegerischer Seite vor allem Einfühlsamkeit, Behutsamkeit, Respekt und Würde gegenüber dem Menschen und seiner Lebensleistung und pflegerische Professionalität voraus.

Es ist die Aufgabe jeder Pflegekraft sich intensiv mit den Grundprinzipien der Sterbegleitung auseinanderzusetzen, an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu diesem Thema haben alle Mitarbeiter teilzunehmen.

Innerhalb des Umgangs mit unseren Pflegebedürftigen im Rahmen der Sterbegleitung bzw. im Umgang mit Verstorbenen legen wir nachfolgende Regelungen fest.

Sterbegleitung

Im Rahmen der Informationssammlung sollen Wünsche und Vorstellungen des Pflegebedürftigen zur letzten Lebensphase erfasst werden. Auf Wunsch erfolgt eine Vermittlung einer psychologischen oder seelsorgerischen Sterbegleitung (z. B über einen Hospizdienst).

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz und die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin legen folgende Schwerpunkte zur Sterbegleitung fest:

- Symptombehandlung
- Zuwendung für Patienten und Angehörige
- Patientenbeobachtung
- Kommunikation
- Erfassung von Bedürfnissen im physischen, psychischen, sozialen und spirituellen Bereich, Einbeziehung der Angehörigen

Unsere Begleitung Sterbender innerhalb unserer Einsätze orientiert sich des Weiteren an den Leitsätzen der „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen“ 2010

Leitsatz 1:

Gesellschaftspolitische Herausforderungen – Ethik, Recht und öffentliche Kommunikation

Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Sterben unter würdigen Bedingungen. Er muss darauf vertrauen können, dass er in seiner letzten Lebensphase mit seinen Vorstellungen, Wünschen und Werten respektiert wird und dass Entscheidungen unter Achtung seines Willens getroffen werden. Familiäre und professionelle Hilfe sowie die ehrenamtliche Tätigkeit unterstützen dieses Anliegen. Ein Sterben in Würde hängt wesentlich von den Rahmenbedingungen ab, unter denen Menschen miteinander leben. Einen entscheidenden Einfluss haben gesellschaftliche Wertvorstellungen und soziale Gegebenheiten, die sich auch in juristischen Regelungen widerspiegeln. Wir werden uns dafür einsetzen, ein Sterben unter würdigen Bedingungen zu ermöglichen und insbesondere den Bestrebungen nach einer Legalisierung der Tötung auf Verlangen durch eine Perspektive der Fürsorge und des menschlichen Miteinanders entgegenzuwirken. Dem Sterben als Teil des Lebens ist gebührende Aufmerksamkeit zu schenken.

Freigabe durch	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	I	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle IV.5	Bezeichnung des Dokumentes: Sterbegleitung und Versorgung Verstorbener Umgang mit Nachlass in unserem Pflegedienst	

Leitsatz 2:

Bedürfnisse der Betroffenen – Anforderungen an die Versorgungsstrukturen

Jeder schwerstkranke und sterbende Mensch hat ein Recht auf eine umfassende medizinische, pflegerische, psychosoziale und spirituelle Betreuung und Begleitung, die seiner individuellen Lebenssituation und seinem hospizlich-palliativen Versorgungsbedarf Rechnung trägt. Die Angehörigen und die ihm Nahestehenden sind einzubeziehen und zu unterstützen. Die Betreuung erfolgt durch haupt- und ehrenamtlich Tätige soweit wie möglich in dem vertrauten bzw. selbst gewählten Umfeld. Dazu müssen alle an der Versorgung Beteiligten eng zusammenarbeiten. Wir werden uns dafür einsetzen, dass Versorgungsstrukturen vernetzt und bedarfsgerecht für Menschen jeden Alters und mit den verschiedensten Erkrankungen mit hoher Qualität so weiterentwickelt werden, dass alle Betroffenen Zugang dazu erhalten. Die Angebote, in denen schwerstkranke und sterbende Menschen versorgt werden, sind untereinander so zu vernetzen, dass die Versorgungskontinuität gewährleistet ist.

Leitsatz 3:

Anforderungen an die Aus-, Weiter- und Fortbildung

Jeder schwerstkranke und sterbende Mensch hat ein Recht auf eine angemessene, qualifizierte und bei Bedarf multiprofessionelle Behandlung und Begleitung. Um diesem gerecht zu werden, müssen die in der Palliativversorgung Tätigen die Möglichkeit haben, sich weiter zu qualifizieren, um so über das erforderliche Fachwissen, notwendige Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie eine reflektierte Haltung zu verfügen. Für diese Haltung bedarf es der Bereitschaft, sich mit der eigenen Sterblichkeit sowie mit spirituellen und ethischen Fragen auseinanderzusetzen. Der jeweils aktuelle Erkenntnisstand muss in die Curricula der Aus-, Weiter- und Fortbildung einfließen. Dies erfordert in regelmäßigen Zeitabständen eine Anpassung der Inhalte. Wir werden uns dafür einsetzen, dass der Umgang mit schwerstkranken und sterbenden Menschen thematisch differenziert und spezifiziert in die Aus-, Weiter- und Fortbildung der Beteiligten in den verschiedensten Bereichen integriert wird.

Leitsatz 4:

Entwicklungsperspektiven und Forschung

Jeder schwerstkranke und sterbende Mensch hat ein Recht darauf, nach dem allgemein anerkannten Stand der Erkenntnisse behandelt und betreut zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, werden kontinuierlich neue Erkenntnisse zur Palliativversorgung aus Forschung und Praxis gewonnen, transparent gemacht und im Versorgungsalltag umgesetzt. Dabei sind die bestehenden ethischen und rechtlichen Regularien zu berücksichtigen. Zum einen bedarf es der Verbesserung der Rahmenbedingungen der Forschung, insbesondere der Weiterentwicklung von Forschungsstrukturen sowie der Förderung von Forschungsvorhaben und innovativen Praxisprojekten. Zum anderen sind Forschungsfelder und -strategien mit Relevanz für die Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen zu identifizieren. Wir werden uns dafür einsetzen, auf dieser Basis interdisziplinäre Forschung weiterzuentwickeln und den Wissenstransfer in die Praxis zu gewährleisten, um die Versorgungssituation schwerstkranker und sterbender Menschen sowie ihrer Angehörigen und Nahestehenden kontinuierlich zu verbessern.

Leitsatz 5:

Die europäische und internationale Dimension

Freigabe durch	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	2	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle IV.5	Bezeichnung des Dokumentes: Sterbegleitung und Versorgung Verstorbener Umgang mit Nachlass in unserem Pflegedienst	

Jeder schwerstkranke und sterbende Mensch hat ein Recht darauf, dass etablierte und anerkannte internationale Empfehlungen und Standards zur Palliativversorgung zu seinem Wohl angemessen berücksichtigt werden. In diesem Kontext ist eine nationale Rahmenpolitik anzustreben, die von allen Verantwortlichen gemeinsam formuliert und umgesetzt wird. Wir werden uns für die internationale Vernetzung von Organisationen, Forschungsinstitutionen und anderen im Bereich der Palliativversorgung Tätigen einsetzen und uns um einen kontinuierlichen und systematischen Austausch mit anderen Ländern bemühen. Wir lernen aus deren Erfahrungen und geben gleichzeitig eigene Anregungen und Impulse.

Unsere Begleitung Sterbender orientiert sich ebenso an Grundzügen der von Kübler- Ross dargestellten Phasen des Sterbeprozesses:

- Nicht-Wahrhaben-Wollen
- Zorn-Auflehnung-Wut
- Verhandeln mit dem Schicksal
- Depression
- Innere Ruhe

Wichtig für uns ist die Betreuung von Angehörigen. Die Leistungen der Sterbegleitung erfolgt vor allem im Rahmen unserer Einsätze. Soweit möglich sind die Grundsätze der Basalen Stimulation zu berücksichtigen. Die nachstehenden Hinweise sind zu berücksichtigen. Jeder Mitarbeiter hat sich mit den religiösen Besonderheiten und Wünschen unserer Patienten auseinanderzusetzen und diese in der Betreuung zu berücksichtigen.

Im Rahmen der Palliativversorgung hat eine enge Abstimmung zum gemeinsamen Vorgehen mit dem Arzt zu erfolgen. Wir arbeiten mit dem Ambulanten Hospizdienst in Wolfen und Leipzig zusammen.

Dort wo es möglich und vertretbar ist, sind Leistungen der SAPV –RL (Spezialisierte Ambulante Palliativversorgungsrichtlinie veröffentlicht am 11.03.2008) mit zu berücksichtigen.

Nachstehende Hinweise sind zu beachten:

Symptomatik Auffälligkeit	pflegerisches Angebot	Hinweise				
Freigabe durch	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	3	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle IV.5	Bezeichnung des Dokumentes: Sterbegleitung und Versorgung Verstorbener Umgang mit Nachlass in unserem Pflegedienst	

Angst (Todesangst) Unruhe	Ermöglichung, die Sterbezeit mit geringer Angst zu bewältigen Unruhezustand lindern	Pflegebedürftigen möglichst in gewohnter Umgebung sterben lassen, Verlegung in ein Krankenhaus möglichst vermeiden, durch Geduld, Einfühlungsvermögen verbal und/oder nonverbal, Anteilnahme, Verständnis und Zuneigung vermitteln
Alleingelassen fühlen	Gefühl von Geborgenheit geben	Gefühl von Ruhe und Geborgenheit geben (dies bedarf auch der Bereitschaft sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen), angsthemmende und beruhigungsfördernde Medikamente, ggf. nach ärztlicher Anordnung, Seelsorge anbieten, Angehörige in die Betreuung mit einbeziehen, Gebete, Glaubensgespräche wenn gewünscht
Schmerzen	schmerzfreie Sterbezeit	Schmerzbekämpfung nach ärztlicher Anordnung (bei Schmerztherapie bleibt der Sterbende bei Bewusstsein und kommunikationsfähig (siehe Standard) psychosoziale Betreuung und Beruhigung (individuell, verbal, nonverbal)
Appetitlosigkeit	Appetit anregen zur Aufwertung des Allgemeinbefindens	Wunschkost mehrmals täglich anbieten, optisch schönes Herrichten der Speisen usw.
Fieber / erhöhte Temperatur	Fiebersenkung	als Teil behandlungspflegerischer Maßnahmen
Erkrankung des Mund- u. Rachenraumes (durch stark verringerte oder keine Kautätigkeit)	Vermeidung solcher Erkrankungen	mehrmals täglich spezielle Mundpflege ausüben (s. Standard „Mundpflege“)
täglich benötigte Flüssigkeitszufuhr kann nicht mehr aufrecht erhalten werden	täglich Flüssigkeitsbedarf ermitteln und absichern	Sterbenden täglich oft Getränke anbieten (individuelle Geschmacksrichtung berücksichtigen), ist eine orale Aufnahme nicht mehr möglich, täglichen Flüssigkeitsbedarf teilweise in Absprache mit Arzt sichern
Lippen- und Mundtrockenheit	Erhaltung feuchter Lippen und Mundraum	regelmäßige Flüssigkeitsaufnahme (wenn möglich), Lippen regelmäßig mit Fettsalbe behandeln, anfeuchten des Mundraumes und der Zunge mit Tee o.ä. getränkter Kompressen, anfeuchten der Luft
erschwerte Atmung	Atmung erleichtern	Atemwege kontrollieren, freihalten (evtl. vorhandenen Schleim im Mund- u. Rachenraum absaugen), Oberkörper hochlagern (evtl. mit Abduktion der Arme) je nach individuellen Bedingungen, Frischluftzufuhr, Ruhe vermitteln (verbal oder nonverbal,

Freigabe durch	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	4	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle IV.5	Bezeichnung des Dokumentes: Sterbegleitung und Versorgung Verstorbener Umgang mit Nachlass in unserem Pflegedienst	

		individuell), Medikamente (entspannend, krampflösend) nach ärztlicher Anordnung
Haut- veränderungen	intakte Haut	tägliche Ganz- oder Teilwaschung (individuell) mit allgemeiner Hautpflege (s. Standard „Ganzwaschung“), sorgfältige Inkontinenzversorgung und Intimpflege, Hautpflege der kritischen Hautpartien (s. Standard „Dekubitusprophylaxe“), regelmäßige Umlagerung nach individuell besprochenem Bewegungsplan (Lieblingslage beachten und berücksichtigen)

Hinweise :	Grundsätzliches :
unsichere Todeszeichen sind: • Atemstillstand • Kein Herzschlag, kein Puls • weich werdende Augäpfel • fehlender Pupillenreflex	Die Versorgung Verstorbener hat folgendermaßen zu geschehen: • alle Handlungen erfolgen immer unter Achtung der Würde und dem Respekt vor der Persönlichkeit des Verstorbenen • die Pflegefachkraft macht die Schlechtmeldung

Freigabe durch	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	5	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle IV.5	Bezeichnung des Dokumentes: Sterbegleitung und Versorgung Verstorbener Umgang mit Nachlass in unserem Pflegedienst	

- fahle Gesichtshaut sichere Todeszeichen sind: - Leichenstarre (4-12 Std. nach Exitus) - Leichenflecken (blassrot, später dunkelrot bis blaugrau an der Unterseite des Körpers) - Fehlen jeglicher Hirnströme - Trübung der Augenhornhaut, weite Pupillen Literaturhinweise zur Sterbegleitung: - Interviews mit Sterbenden / E. Kübler-Ross - Sterbebeistand, Sterbegleitung, Sterbegeleit/ Studienbuch Franco Rest	(Einleitung der Sterbephase) gegenüber den Angehörigen - je nach Situation des Auffindens sind zuerst die Vitalzeichen zu erheben - der Zeitpunkt des vermeintlichen festgestellten Todes muss exakt im Pflegebericht notiert werden. - der Hausarzt bzw. Bereitschaftsarzt ist umgehend zur Todesfeststellung zu informieren. - der Hausarzt bzw. Bereitschaftsarzt stellt den Tod fest und fertigt den Totenschein. - die PDL ist zu informieren - die Angehörigen sind zu informieren und emotional bzw. organisatorisch, wenn gewünscht, zu betreuen - sind keine Angehörigen vorhanden/verfügbar ist das zuständige Ordnungsamt zu informieren - der Verstorbene wird flach gelagert - Kissen, Decken, Lagerungshilfsmittel werden entfernt - Katheter werden entfernt - der Verstorbene wird evtl. mit Nachthemd o.ä. bekleidet - auf Wunsch der Angehörigen erfolgt eine oberflächliche Reinigung (Ausscheidungen etc.) - die Hände entweder über dem Körper falten oder seitlich anlegen - der Verstorbene wird mit einem Tuch zugedeckt - der Verstorbene wird so gelegt, dass Angehörige und Freunde von ihm Abschied nehmen können. - Alle weiteren Formalitäten werden nur nach Absprache und in Vollmacht der Angehörigen erledigt. - Abgabe aller Unterlagen des Verstorbenen zur Abrechnung und Archivierung an die Verwaltung - Regelung von Nachlasssachen - je nach Einzelfall Teilnahme an der Bestattung - Angehörige eines Verstorbenen erhalten ein Beileidskarte
---	---

Der Umgang mit Nachlasssachen bei der Verwaltung von Bargeldern/ Wertsachen (V.17)

- Im Rahmen des Abschlusses des Pflegevertrages ist ein Berechtigter zum Empfang des Nachlasses unabhängig von der tatsächlichen Erbberechtigung durch den Patienten festzulegen.
- Ist kein Berechtigter festgelegt, so ist der Hauptberechtigte zur Entgegennahme des Nachlasses im Sinne des BGB der Erbberechtigte, dieser hat den Erbschein des Nachlassgerichtes vorzulegen.

Freigabe durch	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	6	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle IV.5	Bezeichnung des Dokumentes: Sterbegleitung und Versorgung Verstorbener Umgang mit Nachlass in unserem Pflegedienst	

Freigabe durch	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	7	Verw./MA